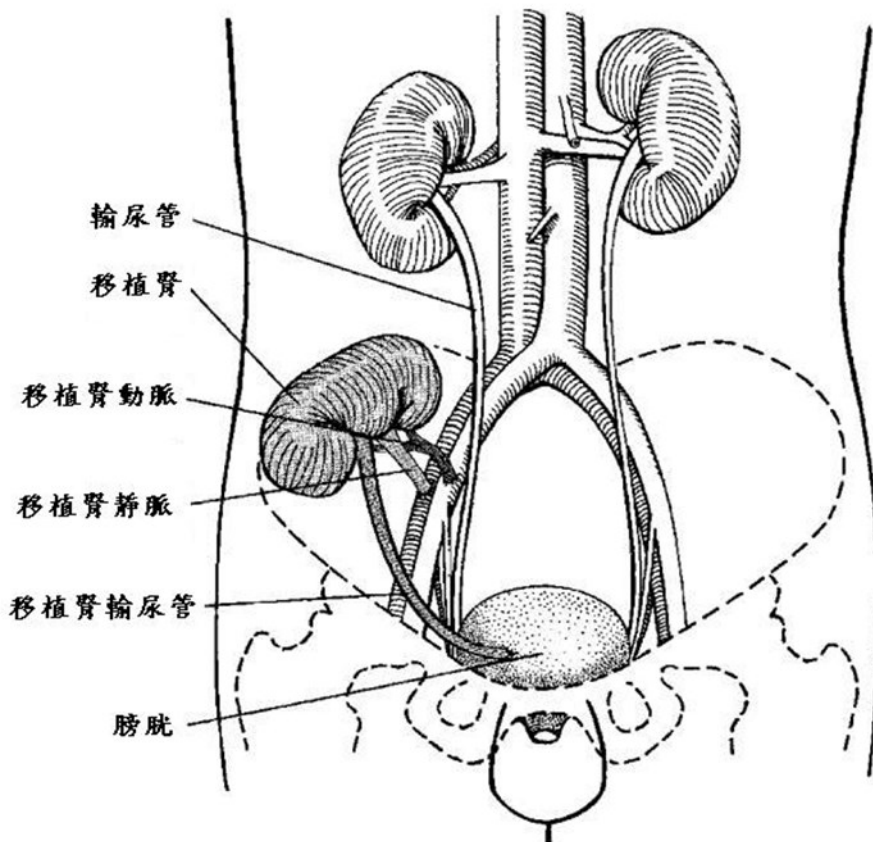


腎臟移植術後照護



生效日期：100/01/31 修正日期：112/12/07
檢閱日期：114/12/05 編號：T-Adult-148



目錄

前言	3
腎臟移植簡介.....	5
移植前手術前評估：	5
腎臟移植的禁忌：	6
腎臟移植手術	7
移植後常見合併症	9
1. 心臟血管合併症	9
2. 惡性腫瘤	9
3. 感染	10
4. 移植後糖尿病	11
5. 排斥	11
認識抗排斥藥物	13
服用藥物注意事項	13
抗排斥藥物	15
抗排斥藥之藥物交互作用	21
其它移植後常用藥物	22
術後居家照護重點	23
腎臟科門診追蹤注意事項	30
相關社會支持團體	31



前言

尿毒症是一種會危及生命的長期慢性疾病，治療方法除了長期透析治療外，另外則是腎臟移植。

「腎臟移植」為腎臟衰竭末期的積極外科治療，讓許多病人於手術後改善了生活品質，重返自己的人生舞台。隨著免疫抗排斥藥物、組織配對及手術技術的進步，使得腎臟移植病人的存活率不斷上升。

歷經長時間的期待與等候，恭喜您換得了一顆新的腎臟，步入人生的另一段新生活。在移植手術後，新的腎臟已經開始發揮功能，此時您身體大部分生理機能障礙都逐漸的獲得改善，甚至恢復正常。雖然如此，日後仍有可能出現各種狀況，影響腎臟與其他身體機能。因此，您需要定期至腎臟科門診



追蹤，並且按時服藥。請與我們攜手合作，共同照顧您自身的健康。

本手冊將提供腎臟移植後的居家照顧觀念，適應新生活的改變，如果您身體有上任何不適或健康上的疑問，請隨時與腎臟科連絡。



腎臟移植簡介

目前可分為分類：

- 一. 活體移植：包含五等親內之血緣親屬及非血緣親屬(夫妻捐贈)。
- 二. 屍腎移植：腦死病人家屬同意而捐贈的腎臟。

移植前手術前評估

除了抽血及尿液檢查、心電圖、胸部X光、腹部超音波、腎臟核子醫學檢查、及相關病毒檢驗外，還有血型、組織型態(HLA Tissue Typing)及交叉試驗(cross matching)，又稱淋巴球毒性試驗(Lymphocyte toxicity test)。登記腎臟移植約每三至六個月，須回腎臟科門診追蹤與抽血。



腎臟移植的禁忌

1. 年齡太大者(超過 65 歲以上)
2. 有嚴重的心臟病或血液循環系統病變的病人
3. 嚴重的肺功能障礙病人
4. 癌症病史而有可能合併轉移者
5. 心智能力退化者(如控制不良的精神病人)
6. 愛滋病病人
7. 習慣性濫用藥物者



腎臟移植手術

腎臟移植是末期腎衰竭（洗腎）病人治療的優先選擇，但此方式並非絕無風險。接受移植者需提早入院，以便在手術前有充足時間進行檢查與評估。

腎臟移植手術採全身麻醉，下腹部會有一處斜彎型傷口（右下腹或左下腹），腎臟置於近膀胱旁的前腹腔骨盆窩。手術中需進行腎臟動脈、靜脈與接受者腸骨動脈、靜脈的吻合並將捐贈者的輸尿管縫合於接受者的膀胱，術後會留置引流管、導尿管，待恢復情況再拔除。手術時間約3-5小時。至於原有腎臟或之前失敗的移植腎是否要切除，則因情況而異。



如果過程順利，移植後病人很快會有小便產生，
有時候新的腎臟不會馬上有功能，這稱為移植腎功
能延遲；大部分約14~21天內新腎會逐漸發揮功能，
最長約70天左右，尿量會恢復至正常。



移植後常見合併症

1. 心臟血管合併症

心血管疾病是影響移植病人生命的主要因素，亦是造成移植患者死亡的主要原因，40%的移植病人死亡原因是心血管疾病。移植術後高血壓、糖尿病與高膽固醇血症是增加心血管疾病發生的關鍵危險因素。可能原因有抗排斥藥及類固醇的副作用、排斥、腎動脈狹窄、高血脂、復發性腎病等。

如果血壓沒控制好，可能導致腦中風、心臟衰竭、心肌梗塞、腎臟衰竭等嚴重後果。

2. 惡性腫瘤

腎臟移植手術後，病友發生癌症的機率也比



正常人高很多。每一種癌症都可能發生，但國人較常見的是泌尿道癌症(膀胱癌、腎臟癌)、肝癌。因此，除了定期的超音波掃描外；若有血尿情形，則應接受尿液的癌細胞篩檢，及膀胱鏡等檢查。另外若有體重減輕、大便習慣改變、久咳或身上有硬塊時，也要儘快與醫師討論，以便早期診斷、提早治療。因大部分的癌症，只要早期發現及早期治療，都會有比較好的存活率。

3. 感染

抗排斥藥物會抑制體內的免疫系統，同時也增加病人感染的機率，這是所有移植人最大的擔憂；嚴重的感染常常是移植人死亡的重要原因之一。



4. 移植後糖尿病

移植後糖尿病是器官移植後常見的一種併發症，發生率約為5-27%。定義為移植前無糖尿病史，移植後發生持續性高血糖情形。原因複雜且與多種免疫抑制劑有關，其中皮質類固醇、環孢靈及普樂可復較容易造成血糖升高。特別是普樂可復，根據研究顯示環孢靈及普樂可復引發移植後糖尿病的風險分別為2.7%及9.8%。

5. 排斥

『排斥反應』是移植後常見的併發症之一。急性排斥反應可以在腎臟移植後的任何時間發生，但以移植後最初的六個月內最常見。急性排斥的症狀可能包括：移植腎有疼痛感、尿量減少、水腫、全



身感覺不舒服和發燒等。要抑制急性排斥，得靠免疫抑制劑(抗排斥藥物)。排斥藥通常需長期服用，隨著移植的時間越久，使用劑量也會逐漸減少。



認識抗排斥藥物

服用藥物注意事項

1. 每次回診領藥後，請務必確實清點藥物種類及數量，有任何的疑問立即詢問醫師及藥師澄清。
2. 藥品應存放於室溫，避免放在浴室、高溫或曝露太陽下。
3. 移植術後，抗排斥藥必須依照醫師所指示的劑量按時服用，不可提前、延後或忘記服用藥物，否則會影響病情。
4. 服用藥物後 30 分鐘到 1 小時內，如有嘔吐的情形，請詢問醫師，是否需再補服藥物，勿自行決定是否再服用一次的藥物。



5. 服藥後有任何不適的情形，請與醫師聯絡或立即返診。

6. 不可自行服用未經醫師同意的藥物（包括中藥或偏方、健康食品），若有經其他醫師處方的藥品，請與主治醫師討論，以免影響抗排斥藥物的作用或造成其他的副作用。

7. 未經醫師指示，不可任意施打預防針、疫苗。

如果需要進行手術，包括牙科，告知醫師或牙醫師正在服用此藥。

8. 請隨身攜帶卡片，上面記錄姓名、疾病、使用的藥品及劑量、醫院電話等。



抗排斥藥物

抗排斥藥物種類眾多，而這些藥物可以降低病友發生排斥的機率及延長新腎存活率。但藥物多少會引起副作用，會隨劑量及每個人狀況而有所不同；千萬不可自行停藥或改變劑量，因為劑量不足可能會導致新腎受到排斥而失去功能。以下介紹為目前常見的抗排斥藥物：

山喜多（Cellcept®；MMF）

每顆 250mg，外表為橘/藍色膠囊，每天早餐及晚餐飯前 30 分鐘服用，因飯後制酸劑會影響山喜多吸收，與普樂可復(FK506)併用時，兩者可相隔 1-2 小時，以免腸胃不適。常見副作用：腹瀉、噁心、嘔吐、白血球及血小板減少、貧血、胃潰瘍、腸胃道出血，使用期間須定期監測血中血紅



素、白血球及血小板。

睦體康 (Myfortic®)

每顆 180mg，外表似酪梨顏色錠劑，每天早餐及晚餐前 30 分鐘服用。主要作用與山喜多相同，所以不會與山喜多一起服用。請整顆吞服，勿咬碎或磨粉，服用此藥的前後 2 小時請不要服用制酸劑。副作用包括：胃腸不適、發燒、失眠、水腫、粉刺、影響血球功能、高血壓、高血脂等。治療前、期間及停止治療後 6 週內，應採取有效避孕措施。





新體睦、環孢靈

(Sandimmun® ; Neoral ; Cyclosporin A)

有 25mg 及 100mg 兩種劑型，外表為灰色膠囊，每天早上及晚上固定時間服用(間隔 12 小時)，可以和食物一起服用。常見副作用：多毛症、震顫、肝功能不全、腎臟毒性、血壓高、胃腸障礙(噁心、嘔吐)、牙齦肥厚等等。如果劑量太高，手部可能出現不自主顫動或感覺麻木，所以須定時監測血中濃度，以調整劑量。

普樂可復 (Prograf® ; Tacrolimus ; FK506)

有 0.5mg (黃色膠囊)、1mg (白色膠囊)及 5mg (紅色膠囊)三種劑型，作用機轉和環孢靈相似，每天早上及晚上固定時間服用 (間隔 12 小時)，環





孢靈與普樂可復只能擇一使用。副作用：噁心、嘔吐、腹瀉、四肢顫抖、頭痛、皮膚癢、血糖升高、毛髮脫落等情況，因此定期監測血中普樂可復濃度，調整劑量，而維持正常血中濃度，可降低腎毒性的發生。

安瑞福持續性藥效膠囊 (Advagraf®；

Prolonged-release capsule, Tacrolimus)

普樂可復長效型劑量，一天只要服用一次，有0.5mg (黃色/橘色膠囊)及1mg (白色/橘色膠囊) 兩種劑型，可以在飯前1小時或飯後2-3小時服用，但每日使用方法及服用時間須固定。注意事項與普樂可復相同。





類固醇（Prednisolone；普力多寧錠）

每顆 5mg，外表白色小顆粒，每天早餐後服用。臨床上常用，可抗發炎及抗排斥，剛開始使用劑量較高，會慢慢降低劑量。副作用有體型改變（月亮臉、腹圓、水牛肩）、胃口變好、體重增加、容易感染、腸胃不適、皮膚容易受傷及瘀血、傷口癒合慢、肌肉關節無力或輕微疼痛、血糖升高。

斥消靈（Rapamune®；Sirolimus）

每顆 1mg，外表為白色三角形錠劑，一天一次，每天服藥時間須固定，如果同時須使用環孢靈或普樂可復，應在環孢靈或普樂可復服用後 4 小時才可服用此藥。可能引起的副作用有高血脂、口腔潰瘍、





腹痛、腹瀉、便秘、嘔吐，發燒、不正常的出血或瘀血、血尿、血便或黑便、四肢水腫、呼吸困難、高血壓、皮膚紅疹、肌肉疼痛、黃疸症狀、傷口併發症等。服藥勿授乳；如欲懷孕，須告知醫師。

卓定康錠 (Certican®； Everolimus)

有 0.25mg 及 0.5mg 兩種劑型，外表為白色錠劑，每天早上及晚上固定時間服用(間隔 12 小時)，可與環孢靈或普樂可復一起服用。副作用與斥消靈相同。





抗排斥藥之藥物交互作用

會增加環孢靈/普樂可復血中濃度的藥物

1. 巨環類抗生素：Erythromycin、Clarithromycin
2. 黴菌感染藥物（治療香港腳藥物）：Voriconazole、Fluconazole、Itraconazole、Ketoconazole。
3. 鈣離子通道阻斷劑：Diltiazem、Verapamil、Nicardipine。
4. 其他：Cimetidine、Bromocriptine、Ciprofloxacin、Metoclopramide、SSRI、Narinenin(柚皮素)。

會降低環孢靈/普樂可復血中濃度的藥物

1. 治療結核菌感染藥物：Rifamycin。
2. 抗癲癇藥物：Carbamazepine、Phenytoin、Phenobarbital。





3. 其他：Orlistat(羅氏鮮) 、 St.John's Wort 、
Terbinafine 等。

其它移植後常用藥物

移植後醫師會視個人狀況合併其他藥物，包
括：高血壓藥、降血糖藥、利尿劑、降血脂藥物、
抗生素等。



術後居家照護重點

❖ 學習每天自我監測並記錄體重、體溫、血壓、
血糖等（體重每天早上一次，血壓及血糖一天
兩次）；評估大便顏色、性質與尿量。

※如果有下列情況發生，請立即與腎臟科連絡或
至門診、急診就醫：

1. 手術傷口紅、腫、痛或有分泌物流出。
2. 體溫超過 38°C ，持續 24 小時。
3. 一天內體重增加一公斤以上或一周增加兩公斤
以上。
4. 呼吸急促，喘不過氣來。
5. 皮膚起疹或水泡。





❖ 了解器官移植後的排斥反應。

- 1.發燒：體溫大於 38°C ，持續一天以上。
- 2.一天的尿量少於 1000c.c。
- 3.體重持續增加，一天一公斤以上。
- 4.移植的腎臟腫痛，移植腎同側的腿浮腫。
- 5.身體感莫名的焦躁不適或倦怠。
- 6.不可擅自停藥或調藥。

❖ 活動

移植手術後的三個月內不宜提重物及過分劇烈的運動，如騎馬、賽車等；而散步、踏青、爬山、等都是最好的活動。若開車，應避免安全帶壓迫腹部，尤其是移植的腎臟處。三個月後雖可





參與任何活動，仍應避免身體碰撞的活動。部分劇烈運動，如游泳等，應於術後 6 個月才可進行。

❖ 飲食

若新腎還未完全發揮作用，血中的肌酸酐仍偏高及尿量仍少時，此時須暫時依照洗腎時的飲食注意事項；若新腎功能良好，則必須注意體重及水分的攝取，以免因新腎發揮功能，尿液過多而造成脫水。

飲食攝取須均衡規律，注意食物新鮮、烹調以全熟為宜，禁止生食（例如：生魚片、生菜沙拉、未煮熟的荷包蛋、海產食物）。

禁止服藥時與葡萄柚汁或果汁飲料併用，尤其是抗排斥藥或降血壓藥物。





請選擇須削皮水果，避免食入果皮上的微生物。若無法削皮水果，請用流動的自來水洗淨並削去蒂的部分。

出院後長期追蹤時，由於某些藥物可能造成高血壓、高血糖或高血脂等副作用，除了適度運動，可保持適當體重及身材，最重要是培養健康的飲食習慣，如低鹽、低脂或低糖等。低鹽飲食同時可減少身體水份滯留或改善高血壓現象。

❖ 工作

在身體狀況恢復時，恢復一如往常的工作，盡量不要從事過於粗重或熬夜的工作。





❖ 性生活、生育

身體狀況恢復，夫妻間即可恢復正常性生活，性姿勢以不壓迫新腎為原則；但某些藥物可能多少會有性功能失常問題，可和主治醫師討論用藥劑量或改藥。如有生育計畫，請與醫師討論，而女性病人應避免移植後一年內懷孕。

❖ 定期返診追蹤

在門診會定期抽血，追蹤腎功能及抗排斥藥濃度，作為治療及調整藥物的依據，為您的新腎做最好的健康把關。





❖ 鼓勵參與術後支持團體

依病友的背景、價值觀、手術後恢復情況不同，會產生各種不同程度的心理反應，擔心、害怕、嚴重者甚至有焦慮、憂慮的情形，鼓勵加入的病友們，可以在此找到經驗相同的人，彼此分享、扶持與成長。此時家人重大，您的陪伴及耐心，使患者不會感受到自己是孤獨的，也是腎臟移植病友最大的安慰及精神支柱。

❖ 日常生活注意事項

1. 應避免飼養寵物、接觸野生動物、禽鳥或花粉。
2. 注意個人衛生習慣，不與他人共用盥洗器具及刮鬍刀。





3. 加強口腔照護，尤其每次進食後須刷牙或漱口。
4. 每天睡眠充足、養成規律的生活作習，請勿熬夜、太過操勞。
5. 觀察有無腹瀉情形，若持續 12~24 小時且呈水便，建議回院求診，以防免疫抑制劑吸收不佳或是症狀持續惡化。





腎臟科門診追蹤注意事項

我們會與您約定門診時間，請您務必準時就診；每次門診都需要抽血檢驗腎功能與抗排斥藥的藥物濃度，請您務必在門診當天早上前至檢驗科抽血，【抽血若無特殊指示，抽血並不需空腹禁食，但一定要在與您前一天晚上服用抗排斥藥的時間剛好隔 12 小時抽血，且須早上抽完血後，才可服用早上的抗排斥藥】。若您手邊沒有抽血檢驗單，可先至診間報到，並請醫師先幫您開立驗血單後，再至檢驗科抽血。

在您看診後，我們也會與您約定下次門診時間及開立下次門診的抽血檢驗單。





相關社會支持團體

❖ 台中市新腎協會

地址：台中市豐原區忠孝街 105 巷 53 號

電話：04-25237688

網址：<https://www.newkidney.org.tw/index.html>

E-mail：chei.shenn@gmail.com

❖ 候鳥之愛（台大腎臟移植病友）

地址：台北市中山南路 7 號 護理部移植小組

電話：02-23123456 分機：63089、63106

網址

[http://www.ntuhtx.org.tw/ch/group/group_List.asp?
Volumn_ID=455Volumn_ID=455](http://www.ntuhtx.org.tw/ch/group/group_List.asp?Volumn_ID=455Volumn_ID=455)





中山醫學大學 附設醫院
Chung Shan Medical University Hospital

❖ 長庚生命之光聯誼會

網址：<https://m.facebook.com/長庚生命之光聯誼會>

❖ 成大醫院移植腎友會

住址：台南市勝利路 138 號

電話：06-2353535 #3640、#3641

網址：

<https://fayel212121.wixsite.com/nckuhst/blank-4>





中山醫學大學附設醫院
Chung Shan Medical University Hospital

我的筆記：

醫人．醫病．醫心





中山醫學大學附設醫院
Chung Shan Medical University Hospital

移植腎臟照顧好 日後生活沒煩惱

中山醫學大學附設醫院-護理部

♥♥♥♥♥♥真誠的關心您♥♥♥♥♥♥

諮詢電話：

大慶院區 04-24739595 轉分機_____

中興分院 04-22621652 轉分機_____

